

Protocolo de Acesso ao Serviço Especializado em Reabilitação (SER)



**Prefeitura de
Joinville**

SAÚDE



MISSÃO

“Promover saúde e bem-estar para as pessoas.”



VISÃO

“Ser uma instituição ágil e inovadora, atenta as necessidades de integralidade e sustentabilidade, referência em gestão de saúde pública no Brasil.”

VALORES



Orgulho e Paixão

Transparência

Empatia e Cuidado

Eficiência e Inovação

Sustentabilidade e Governança



SECRETÁRIA DA SAÚDE

Daniela Aparecida Gregório França Cavalcante

DIRETORIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

Vanessa Cardoso Pacheco

DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Aline Gabrielle de Souza Berkenbrock

DIRETORIA TÉCNICA

Luana Garcia Ferrabone

GERÊNCIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DISTRITO CENTRO

Bruna Daniela Dumont Ladeira Landmann

GERÊNCIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DISTRITO NORTE

Ana Aparecida Pereira

GERÊNCIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DISTRITO SUL

Elisarb Mirapalhete Rodrigues Vilar

GERÊNCIA DA QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Juliana Antunes Safanelli

GERÊNCIA DE REGULAÇÃO

Franci Maiara Machado

GERÊNCIA DE SERVIÇOS ESPECIAIS

Ana Caroline Giacomini

COORDENAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (SER)

Lidiane Aparecida Guz Gómez

COORDENAÇÃO DO NÚCLEO DE GESTÃO DA QUALIDADE E PROCESSOS

Cibely Schipitoski

ELABORAÇÃO – 2018

Cleide Aparecida Hoffmann Bernardes – Psicopedagoga

Flávia Favaretto – Núcleo de Apoio à Rede de Atenção à Saúde

Simone Aparecida de Souza – Gerência de Regulação

Tamara Rodrigues Pato Salles – Serviço Especializado em Reabilitação

ATUALIZAÇÃO E REVISÃO - 2025

Valquíria Aparecida Duarte

Juliana Safanelli

Lidiane Aparecida Guz Gómez

COLABORAÇÃO

André Paulo Klamt

Átila Rohleder Júnior

Dayana Bortolotti

Luciana Silveira Virgílio



SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	7
1. ENCAMINHAMENTO AO SER.....	8
1.1 Orientações para Encaminhamentos ao SER.....	9
2. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO PARA ENCAMINHAMENTO AO SER - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO.....	9
2.2 Orientações para Encaminhamentos à OPM.....	12
3. CLASSIFICAÇÃO DE CRITÉRIOS E PRIORIDADE DE REGULAÇÃO DO ACESSO AO SER E À CONCESSÃO DE OPM.....	13
3.1. Classificação de Prioridade para o SER.....	13
3.1.1 Usuário com classificação - Agendamento para o SER.....	13
3.1.2 Usuário com classificação Prioridade 1 (P1) SER.....	14
3.1.3 Usuário com classificação Prioridade 2 (P2) SER.....	15
3.1.4 Usuário com classificação Prioridade 3 (P3) SER.....	15
3.2. Classificação de Prioridade para OPM.....	15
4. AGENDAMENTO.....	16
5. ABSENTEÍSMO.....	17
REFERÊNCIAS.....	18
Anexo 01. Fluxograma de Encaminhamento ao Serviço Especializado em Reabilitação (SER).....	20
Anexo 01. Fluxograma de Encaminhamento ao Serviço Especializado em Reabilitação (SER).....	21
Anexo 02. Fluxograma de Encaminhamento à Órtese, Prótese e Meios Auxiliares (OPM).....	22
Anexo 02. Fluxograma de Encaminhamento à Órtese, Prótese e Meios Auxiliares (OPM).....	23



LISTA DE QUADROS E ANEXOS

Quadro 01. Registros necessários para o encaminhamento à OPM.....	8
Quadro 02. Informações necessárias para o encaminhamento ao SER.....	9
Quadro 03. Critérios de Inclusão para reabilitação no SER.....	10
Quadro 04. Critérios de Exclusão para reabilitação no SER.....	11
Quadro 05. Critérios de Inclusão para o encaminhamento à OPM.....	12
Quadro 06. Critérios de Exclusão para o encaminhamento à OPM.....	12
Quadro 07. Manifestações Clínicas para agendamento pós avaliação do regulador.....	13
Quadro 08. Fatores de Risco para a avaliação do regulador para priorização da demanda...	14
Quadro 09. Critérios para prioridade 1 - P1.....	14
Quadro 10. Critérios para prioridade 2 - P2.....	15
Quadro 11. Critérios para prioridade 3 - P3.....	15
Quadro 12. Prioridades em OPM.....	16



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

APS: Atenção Primária à Saúde

AVC: Acidente Vascular Cerebral

DNPM: Desenvolvimento Neuropsicomotor

E-Multi: Equipe Multiprofissional

ESF: Estratégia Saúde da Família

P1: Prioridade 1

P2: Prioridade 2

P3: Prioridade 3

PMV: Procedimento Municipal Vinculado

SER: Serviço Especializado em Reabilitação

OPM: Órteses, Próteses e Meios Auxiliares

SES-SC: Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina

SIG SaudeTech (Olostech): Sistema Integrado de Gestão SaudeTech (Olostech)

SUS: Sistema Único de Saúde

UBSF: Unidade Básica de Saúde da Família

TCE: Traumatismo Cranioencefálico

TRM: Trauma Raquimedular



INTRODUÇÃO

A reabilitação é um componente essencial da atenção à saúde e da garantia da autonomia e participação social das pessoas com deficiência ou com perda funcional.

No contexto do Sistema Único de Saúde (SUS), os serviços de reabilitação têm como finalidade promover a recuperação funcional, prevenir incapacidades, ampliar a inclusão social e melhorar a qualidade de vida dos usuários.

O Serviço Especializado em Reabilitação (SER) é integrante dos Serviços Especiais do Sistema Único de Saúde (SUS) do município de Joinville - SC, com o objetivo de promover ao usuário saúde, autonomia e inclusão social.

De acordo com o artigo 18 da [Portaria nº 793, de 24 de abril de 2012](#), do Ministério da Saúde, o SER é um “...*estabelecimento de saúde habilitado em apenas um serviço de reabilitação...*”.

Considerando que os protocolos de acesso são instrumentos de ordenação dos fluxos de encaminhamento, que qualificam o acesso e viabilizam a atenção integral ao paciente, orientando quanto à competência dos níveis de atenção. A atualização deste protocolo visa orientar e promover o conhecimento referente ao acesso do usuário no Serviço Especializado de Reabilitação, além de instituir critérios e prioridades para a fila regulada do serviço. O SER realiza atendimentos referentes a duas demandas distintas, a reabilitação física e a concessão de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção (OPM) cada uma vinculada a um código específico de Procedimento Municipal Vinculado (PMV), o que implica na formação de filas de acesso independentes.

Quando houver necessidade simultânea de reabilitação e de OPM, o encaminhamento deve contemplar ambos os procedimentos, utilizando os dois códigos correspondentes no sistema regulatório, conforme os critérios específicos que serão detalhados nas etapas a seguir. Os critérios e a classificação de prioridade de regulação seguem as orientações da Portaria nº 252/2021/SMS, de 15 de setembro de 2021 (disponível no processo SEI nº 19.0.088001-3), que “regulamenta a gestão e administração das filas de espera de consultas especializadas, exames, cirurgias e demais procedimentos, bem como o funcionamento da Central Macrorregional de Regulação do Acesso aos Serviços de Saúde em Joinville.”

Assim sendo, este protocolo é um instrumento dinâmico e deve ser revisto regularmente para atualização e implantação de novas tecnologias em saúde.

1. ENCAMINHAMENTO AO SER

O acesso ao Serviço Especializado em Reabilitação (SER) poderá ocorrer por diferentes pontos da Rede de Atenção à Saúde, incluindo a Atenção Primária à Saúde (APS), HMSJ, ambulatórios especializados e outros serviços de saúde, desde que sejam respeitados os critérios de inclusão estabelecidos no protocolo.

O encaminhamento será realizado por profissionais de nível superior, tais como médico, enfermeiro e profissionais da equipe multiprofissional, tanto da APS quanto de outros serviços. Esses profissionais são responsáveis por avaliar e acompanhar os usuários e, ao identificar a necessidade de reabilitação física e/ou OPM e deverão realizar o encaminhamento via Sistema SIG-SaudeTech, utilizando os códigos de Reabilitação/Deficiência Física – PMV 99003158 e Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção (OPM) – PMV 99003157.

Os encaminhamentos provenientes dos demais serviços de saúde, como hospitais e ambulatórios, deverão igualmente seguir os critérios definidos e ser inseridos no sistema regulador para avaliação e autorização do acesso ao serviço.

O usuário que apresentar mobilidade reduzida que necessita de avaliação para concessão de OPMs (órteses e próteses ortopédicas não relacionadas ao ato cirúrgico, e meios auxiliares de locomoção), deverá ser encaminhado à **OPM** via SIG-SaudeTech mencionando o código de **PMV 99003157**, com o descritivo disponível no Quadro 1 - Registros necessários para o encaminhamento à OPM.

Importante: Devem ser mantidos o vínculo e o cuidado compartilhado com a APS durante todo o manejo do usuário no SER.

Quadro 01. Documentação necessária para o encaminhamento à OPM.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O ENCAMINHAMENTO OPM

Para pessoas com mobilidade reduzida que necessitam de avaliação para concessão de órteses e próteses ortopédicas não relacionadas ao ato cirúrgico, e meios auxiliares de locomoção, baseado no Manual Operativo da SES/SC, 2014*, deverá ser registrado na documentação qual a limitação específica do usuário

Orientar o usuário a levar no dia da consulta na APS os seguintes documentos ou cópia para montar o processo:

- Registro Geral (RG) do usuário e, se menor de 18 anos, do responsável também;
- Cadastro da Pessoa Física (CPF) do usuário e, se menor de 18 anos, do responsável também;
- Cartão Nacional de Saúde (CNS);
- Comprovante de Residência;
- Laudo e Raio X do coto original (quando houver).

Fonte: NGA - SES/Joinville, 2024.

**Manual Operativo da SES/SC, 2014* - aprovado na Deliberação 502/Cib/14



1.1 Orientações para encaminhamentos ao SER.

É necessário que o médico, enfermeiro da Estratégia de Saúde da Família (ESF), fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional da Equipe Multiprofissional (eMulti) da APS, ao encaminhar o usuário ao SER, avalie e registre todas as informações previstas no Quadro 01, assegurando que os dados clínicos e funcionais estejam completos ao realizar o encaminhamento.

Além da APS, o encaminhamento também poderá ser realizado por profissionais dos serviços hospitalares, como os pacientes da Unidade de AVC do HMSJ, ambulatórios especializados e outros pontos da RAS, desde que observados os critérios de inclusão definidos neste protocolo.

Todos os encaminhamentos serão analisados pelo **médico regulador**, que realizará a avaliação e priorização conforme a gravidade e o potencial de reabilitação.

Quadro 02. Informações necessárias para o encaminhamento ao SER.

INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O ENCAMINHAMENTO
Descrever as dificuldades físicas do usuário;
Descrever os critérios de inclusão (conforme <u>Quadro a seguir</u>);
Descrever o atraso do DNPM que o usuário apresentar;
Descrever os sinais e sintomas pertinentes com a evolução clínica;
Descrever, caso houver, avaliação anterior de outros profissionais com ou sem confirmação diagnóstica de Deficiência Física;
Descrever, caso houver, o diagnóstico diferencial com transtornos mentais ou do neurodesenvolvimento;
Descrever o momento que aconteceu o evento ou doença que levou à deficiência física;
Descrever se é um usuário estável clinicamente;
Descrever se o usuário tem a necessidade de retaguarda de transporte e de acompanhante responsável;
Descrever se o usuário necessita de acompanhante por demandas clínicas;
Descrever se o usuário realiza atividades de autocuidado sozinho(a).

Fonte: NGA - SES/Joinville, 2024.

2. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO PARA ENCAMINHAMENTO AO SER - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO

2.1. Reabilitação

O acesso ao SER é regulado por critérios técnicos que visam garantir a equidade, transparência e eficiência no atendimento aos usuários, assegurando que os encaminhamentos sejam adequados às demandas de reabilitação e de concessão de Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção (OPM). O serviço contempla duas modalidades de atendimento, vinculadas a códigos distintos de Procedimento Municipal Vinculado (PMV), que geram filas independentes de regulação:

- Reabilitação/Deficiência Física – PMV 99003158
- Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção (OPM) – PMV 99003157

Nos casos em que o usuário apresentar necessidades concomitantes de reabilitação e de OPM, o encaminhamento deverá ser realizado para ambos os procedimentos, utilizando os dois códigos de PMV correspondentes. Para assegurar a correta priorização e o uso racional dos serviços, os encaminhamentos deverão ser realizados somente após a avaliação dos critérios de inclusão e exclusão, conforme descritos nos quadros a seguir. Essa análise prévia é fundamental para a qualificação do acesso, evitando encaminhamentos inadequados e otimizando os recursos disponíveis.

2.1.1. Critérios de inclusão e exclusão para Reabilitação/Deficiência Física no SER

O **SER** atenderá os usuários com deficiência física que apresentarem um ou mais dos critérios de inclusão do Quadro 3, tendo como base o art. 5º do [Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004](#).

Quadro 03. Critérios de Inclusão para reabilitação no SER

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO PARA REABILITAÇÃO NO SER
Usuários com deficiência física que necessitam de duas ou mais terapias para reabilitação;
Usuários com atraso no Desenvolvimento Neuropsicomotor (DNPM) até 2 anos, 11 meses e 29 dias e sem apresentar comorbidade de Deficiência Intelectual e Transtorno do Espectro Autista conforme a Caderneta de Saúde da Criança;
Usuários com alterações neurológicas de origem central e não degenerativas em fase aguda ou subaguda de reabilitação. Ex: Acidente Vascular Cerebral (AVC), Paralisia Cerebral, Trauma Cranioencefálico (TCE), Lesão medular, Mielomeningocele;
Usuários com amputação de membros ou malformações ortopédicas congênitas, em fase aguda ou subaguda, com impacto funcional significativo;

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO PARA REABILITAÇÃO NO SER

Usuários com doenças neuromusculares que cursam com impacto funcional significativo, (Ex: Distrofia muscular de Duchenne, distrofia muscular de Becker, amiotrofia espinhal progressiva, ataxias hereditárias);

Usuários com deficiência física crônica* que não estão reabilitados, ou não atingiram estabilidade funcional, ou que sofreram um novo evento neurológico ou trauma ortopédico de impacto funcional significativo.

Fonte: NGA - SES/Joinville, 2024. *Conforme [Decreto nº 5.296, de 2 de Dezembro de 2004](#).

Os critérios de exclusão para o encaminhamento ao **SER** estão descritos abaixo:

Quadro 04. Critérios de Exclusão para reabilitação no SER

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO PARA REABILITAÇÃO NO SER

Usuário que não preenche os critérios para Deficiência Física;

Usuários com atraso no DNPM até 2 anos, 11 meses e 29 dias com comorbidade de Deficiência Intelectual e Transtorno do Espectro Autista, conforme a Caderneta de Saúde da Criança;

Usuários com doenças degenerativas em estado avançado ou em cuidados paliativos;

Usuários com transtornos mentais graves e/ou persistentes que impossibilitem o atendimento no serviço e/ou coloquem em risco a sua segurança e/ou dos demais usuários, mesmo que apresentem Deficiência Física;

Usuários com Deficiência Auditiva e Visual, **sem** Deficiência Física;

Usuários com diagnósticos ou suspeitas de Deficiência Física residentes em outros municípios.

Fonte: NGA - SES/Joinville, 2024.

2.1.2. Critérios de inclusão e exclusão Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção (OPM) no SER

A OPM atenderá os usuários com um ou mais critérios de inclusão, conforme o quadro abaixo, apresentando mobilidade reduzida, com necessidade de órteses e próteses ortopédicas não relacionadas ao ato cirúrgico, e meios auxiliares de locomoção conforme o Manual Operativo para concessão de órteses e próteses ortopédicas não relacionadas ao ato cirúrgico e meios auxiliares de locomoção, da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina.

Quadro 05. Critérios de Inclusão para o encaminhamento à OPM.

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO PARA O ENCAMINHAMENTO À OPM

Usuários com mobilidade reduzida que necessitam de avaliação para concessão de órteses e próteses ortopédicas, **não relacionadas ao ato cirúrgico**, e meios auxiliares de locomoção, decorrentes de acidentes ou outros traumas baseado no Manual Operativo da SES/SC. *

Usuários com pé diabético com indicação de calçado especial.



Fonte: NGA - SES/Joinville, 2024.

*Manual Operativo da SES/SC, 2014 - aprovado na Deliberação 502/Cib/14

Os critérios de exclusão para o encaminhamento à **OPM** estão descritos abaixo:

Quadro 06. Critérios de Exclusão para o encaminhamento à OPM.

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO PARA O ENCAMINHAMENTO À OPM
Usuário sem indicação para uso de OPM;
Usuário com Deficiência Visual com indicação para auxílios ópticos;
Usuário com Deficiência Auditiva com indicação para aparelho auditivos;
Usuário com pé diabético com indicação de calçado especial solicitado a menos de 1 ano;
Usuários com diagnósticos ou suspeitas de Deficiência Física residentes em outros municípios.

Fonte: NGA - SES/Joinville, 2024.

O **Anexo 01.** Fluxograma de Encaminhamento ao Serviço Especializado em Reabilitação (SER) descreve como deve ocorrer o processo do encaminhamento ao **SER**.

2.2 Orientações para Encaminhamentos à OPM.

É necessário que o médico, enfermeiro da ESF, fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional da Equipe Multiprofissional na Atenção Primária à Saúde ao encaminhar o usuário para **OPM**, avalie e registre no encaminhamento os itens do Quadro 5. Estes usuários terão os seus encaminhamentos avaliados e priorizados pelo médico regulador.

O **Anexo 02.** Fluxograma de Encaminhamento à Órtese, Prótese e Meios Auxiliares (OPM) descreve como deve ocorrer o processo do encaminhamento à OPM.

Importante: Na necessidade de troca dos equipamentos por motivos de mudança na condição física, desgaste do equipamento ou mudança de medidas, as orientações são:

- **OPMs fornecidas pelo município:** o usuário deverá iniciar **um novo** processo de acesso pela UBSF.
- **OPMs fornecidas pelo Estado,** deverão ser **agendados diretamente com o Centro Catarinense de Reabilitação - (CCR) por contato telefônico** com o mesmo. Não havendo a necessidade de retorno ao SER. (e-mail: ccr@saude.sc.gov.br)
link: <https://www.saude.sc.gov.br/index.php/resultado-busca/geral/2164-centro-catarinens-e-de-reabilitacao-ccr>

3. CLASSIFICAÇÃO DE CRITÉRIOS E PRIORIDADE DE REGULAÇÃO DO ACESSO AO SER E À CONCESSÃO DE OPM.



A Central de Regulação Municipal é responsável por receber e avaliar os encaminhamentos destinados ao SER, encaminhados por médico, enfermeiro, fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional da Equipe Multiprofissional (eMulti) da APS, bem como dos encaminhamentos dos hospitais e dos ambulatórios especializados.

Após a análise dos encaminhamentos e a verificação dos critérios descritos no tópico anterior deste protocolo, o médico regulador realizará a classificação de prioridade, com base nas informações clínicas e funcionais apresentadas, considerando o potencial de reabilitação, o risco de agravamento e a necessidade de concessão de Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção (OPM).

3.1. Classificação de prioridade para agendamento no SER.

Após a avaliação do regulador e conforme os critérios de prioridade elencados por ele e considerando as condições descritas no Quadro 07, serão agendados de imediato aqueles que atenderem todos os critérios. Não é estimado prazo para o agendamento, desta forma este ocorre conforme demanda.

Quadro 07. Condições para agendamento imediato após avaliação do regulador

CONDIÇÕES PARA AGENDAMENTO IMEDIATO	
Usuário com até 12 meses de idade	
Usuário com alterações neuromusculares.	
Usuário com até 65 anos	
Com diagnóstico há menos de 4 meses de condição neurológica, súbita, de origem central e não degenerativa (tais como 1º episódio de AVC, TCE, Traumatismo Raquimedular - TRM), com escala modificada de Barthel entre 0 a 75 pontos.	

Fonte: NGQP - SES/Joinville, 2024.

Para a classificação das prioridades, deverão ser considerados os seguintes fatores de risco conforme Quadro 08.

Quadro 08. Fatores de Risco para a avaliação do regulador para priorização da demanda

FATORES DE RISCO PARA PRIORIZAÇÃO DA DEMANDA
Hemorragia intracerebral
Meningite neonatal
Mielomeningocele
Clínica ou alteração laboratorial compatível com síndrome hipóxico-isquêmica
Parada cardiorrespiratória documentada, com necessidade de reanimação e medicação
Apnéias repetidas

Fonte: NGQP - SES/Joinville, 2024.

OBS: Os bebês com até 12 meses, que apresentarem histórico de internação em **UTI Neonatal nos seus primeiros 28 dias de vida**, devem ser encaminhados ao Programa Bebê Precioso, conforme Protocolo de Acesso, disponível no Processo SEI nº 25.0.088137-1.

3.1.2 Usuário com classificação Prioridade 1 (P1) para encaminhamento ao SER.

Serão considerados como **P1** os usuários estáveis clinicamente, com retaguarda de transporte e de acompanhante responsável, com as condições descritas no Quadro 09.

Quadro 09. Critérios para prioridade 1 - P1

PRIORIDADE 1 - P1
Usuário menor de 2 anos, 11 meses e 29 dias
Com atraso no desenvolvimento motor, associado a suspeita ou diagnóstico de condição neurológica (paralisia cerebral, mielomeningocele, doenças neuromusculares), ou de malformações ortopédicas congênitas severas de membros superiores e inferiores (exemplos: artrogripose múltipla congênita, fêmur curto congênito), condições genéticas que apresentem risco elevado para o desenvolvimento de deformidades osteomusculares graves (exemplo: osteogênese imperfeita).
Usuário independente da faixa etária
Com diagnóstico há menos de 6 meses de condição neurológica de origem central e não degenerativa (exemplos: AVC; TCE; TRM), independente da faixa etária e recorrência de episódios.
Com diagnóstico há menos de 6 meses de amputação de membros, independente da faixa etária e recorrência de episódios.

Fonte: NGQP - SES/Joinville, 2024.



3.1.3 Usuário com classificação Prioridade 2 (P2) .

Serão considerados como **P2**, os usuários com as condições descritas no Quadro 10.

Quadro 10. Critérios para prioridade 2 - P2.

PRIORIDADE 2 - P2
Usuário entre de 3 e 6 anos 11 meses e 29 dias de idade:
Com deficiência física com alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física.*
Usuário independente da faixa etária
Apresenta condição neurológica, associada a sinais de deficiência física, cujos sintomas iniciaram há menos de 12 meses, independente da recorrência de episódios;
Apresenta amputação de membros, ocorrida há menos de 12 meses, independente da recorrência de episódios;
Apresenta diagnóstico confirmado por neurologista, há menos de 12 meses, de doenças neuromusculares que cursam com impacto funcional significativo (exemplos: distrofia muscular de duchenne, distrofia muscular de becker, amiotrofia espinhal progressiva, ataxias hereditárias).

Fonte: NGQP - SES/Joinville, 2024.

*Conforme [Decreto Nº 5.296, de 2 de Dezembro de 2004](#).

3.1.4 Usuário com classificação Prioridade 3 (P3) .

Serão considerados como **P3** os usuários com as condições descritas no Quadro 11.

Quadro 11. Critérios para Prioridade 3 - P3.

CRITÉRIOS PARA PRIORIDADE 3 - P3
Usuário independente da faixa etária
Usuário necessita de no mínimo duas terapias distintas e apresenta deficiência física, com alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física.*

Fonte: NGQP - SES/Joinville, 2024.

*Conforme [Decreto Nº 5.296, de 2 de Dezembro de 2004](#).

3.2. Classificação de Prioridade para OPM

Serão consideradas como prioridade o usuário que apresentar as condições descritas no Quadro 12.

Quadro 12. Critérios para Prioridades em OPM

CRITÉRIOS DE PRIORIDADE EM OPM
Prioridade 1 - P1
Coletes (crianças e adolescentes com necessidade de primeiro colete ou troca de colete, ainda em fase com alto potencial de crescimento), órteses para pós operatório de cirurgia de correção de deformidades (p.ex. suropodálicas); Pacientes amputados que necessitam de primeira prótese (p.ex. pós amputação recente); crianças que necessitam de órtese nova ou troca devido ao crescimento.
Prioridade 2 - P2
Troca de próteses para amputações; revisão de próteses (encaixes e/ou outros componentes de próteses); cadeira de rodas ou de banho, almofada de células de ar, almofada simples de gelórteses cruromaleolar, cruropodálicas (tutor longo), inguinopodálicas, pelvicopodálicas, suropodálicas, axilopalmar (splint), dinâmica pélvico-crural, reação ao solo.
Prioridade 3 - P3
Calçados sob medida e calçados ortopédicos, calçados anatômicos para pés neuropáticos, palmilhas, bengala, troca de órtese em adultos, troca de cadeira de rodas ou de banho; bengala de 4 pontos.

Fonte: NGQP, 2024.

4. AGENDAMENTO

O profissional da Central da Regulação da Secretaria da Saúde, entrará em contato telefônico com o usuário para agendamento do primeiro atendimento no SER, conforme agenda disponibilizada pelo serviço. Nos casos em que houver indicação médica expressa de avaliação para OPM através de **atendimento domiciliar**, o agendamento será realizado pela Central da Regulação conforme disponibilidade de agenda pelo Serviço Especializado em Reabilitação destinado para esse fim.

5. ABSENTEÍSMO

O usuário que porventura faltar ao atendimento agendado para consulta no SER, seguirá as regras do absenteísmo, conforme descreve o artigo 16 da Portaria nº 252/2021/SMS, de 15 de setembro de 2021, (disponível no processo SEI nº 19.0.088001-3) da Central de Regulação.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas. **Diretrizes para a implantação de complexos reguladores**. 2ª edição. Brasília – DF: Editora do Ministério da Saúde, 2010.

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **Portaria nº 1.559, de 1º de agosto de 2008**. Institui a Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde – SUS. Brasília – DF: Ministério da Saúde, 2008.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas. **Diretrizes para a implantação de Complexos Reguladores**. Brasília – DF: Ministério da Saúde, 2006.

BRASIL. Presidência da República. **Decreto nº 5.296 de 02 de dezembro de 2004**. Regulamenta as Leis nº 10.048, de que dá prioridade de 08 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. Brasília – DF: 2004.

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. **Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015**. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Brasília – DF: 2015.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. **Diretrizes de Estimulação Precoce: crianças de zero a três anos com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor**. Brasília- DF: Ministério da Saúde, 2016

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **Portaria nº 793, de 24 de abril de 2012**. Institui a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no âmbito do Sistema Único de Saúde. Brasília – DF: Ministério da Saúde, 2012.

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. **Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000**. Estabelecem normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. Brasília - DF: 2000.

BRASIL, Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. **Lei nº 10.048, de 08 de novembro de 2000**. Dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e dá outras providências. Brasília – DF:2000.

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. **Decretos nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999**. Regulamenta a Lei nº7.853, de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora

de Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá outras providências. Brasília – DF:1999.

BRASIL. Presidência da República. **Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990**. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Diário Oficial da União, Poder Executivo, 20 de setembro de 1990. Seção 1. Brasília – DF: 1990.

ESTADO DE SANTA CATARINA. Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina. **Protocolo de Acesso da Regulação Estadual Ambulatorial SES/SC**. Florianópolis – SC: 2016.

ESTADO DE SANTA CATARINA. Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina. **Manual Operativo para concessão de Órteses e Próteses Ortopédicas não relacionadas ao ato cirúrgico e meios auxiliares de locomoção da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina**. Florianópolis – SC: 2014.

ESTADO DE SANTA CATARINA. Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina. **Protocolo de Acesso e Regulação da Regulação Estadual Ambulatorial SES/SC. Reabilitação OPMAL Ingresso**. Florianópolis - SC: 2019.

PREFEITURA DE JOINVILLE. Secretaria Municipal da Saúde. **Portaria SEI – SES.GAB/SES.CAP nº 122/2016/SMS**. Dá nova redação à Portaria SEI 123/2015/SMS, referente à gestão e administração das filas de espera por procedimento de saúde, conforme Central Macrorregional de Regulação do Acesso aos Serviços de Saúde em Joinville. Joinville – SC: 2016.

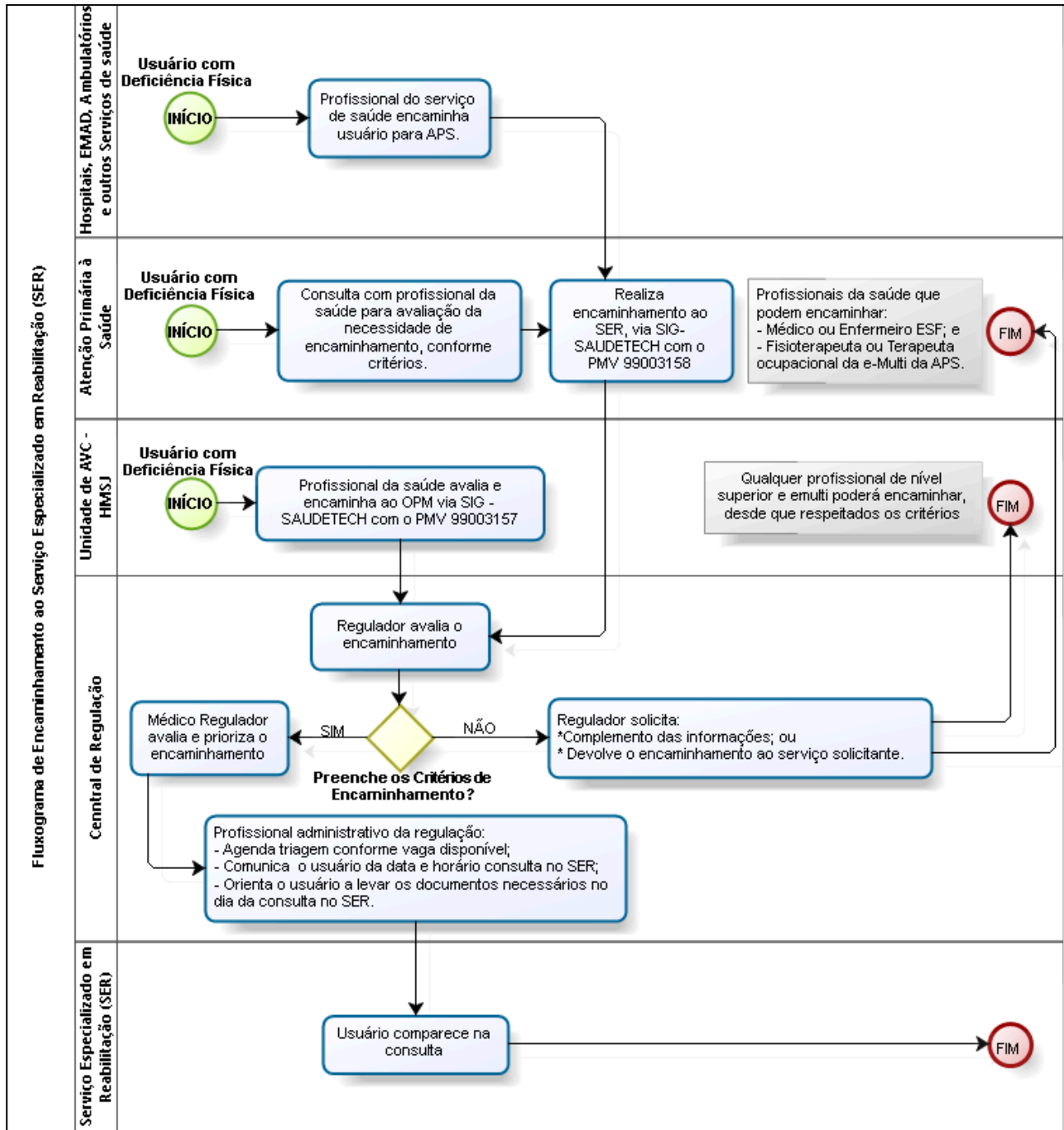
PREFEITURA DE JOINVILLE. Secretaria Municipal da Saúde. **Portaria SEI – SES.GAB/SES.CAP nº 130/2016/SMS**. Institui Protocolos Clínicos, de Acesso e a Regulação Online a serem utilizados na Regulação, na Atenção Primária em Saúde (APS), SAMU, Unidades de Referência, Hospitais Públicos e Contratualizados, incluindo prestadores contratados pelo Município de Joinville e dá outras providências. Joinville – SC: 2016.

PREFEITURA DE JOINVILLE. Secretaria Municipal da Saúde. **Portaria SEI – SES.GAB/SES.CAAP nº 123/2015/SMS**. Estabelece as diretrizes para a gestão das filas de espera na rede de saúde municipal. Joinville – SC: 2015.

PREFEITURA DE JOINVILLE. Secretaria de Saúde. **Portaria SEI – SES.GAB/SES.UAP.APA Nº252/2021/SMS**. Regulamenta a gestão e a administração das filas de espera de consultas especializadas, exames, cirurgias e demais procedimentos, bem como o funcionamento da Central Macrorregional de Regulação aos Serviços em Joinville. Joinville – SC: 2021

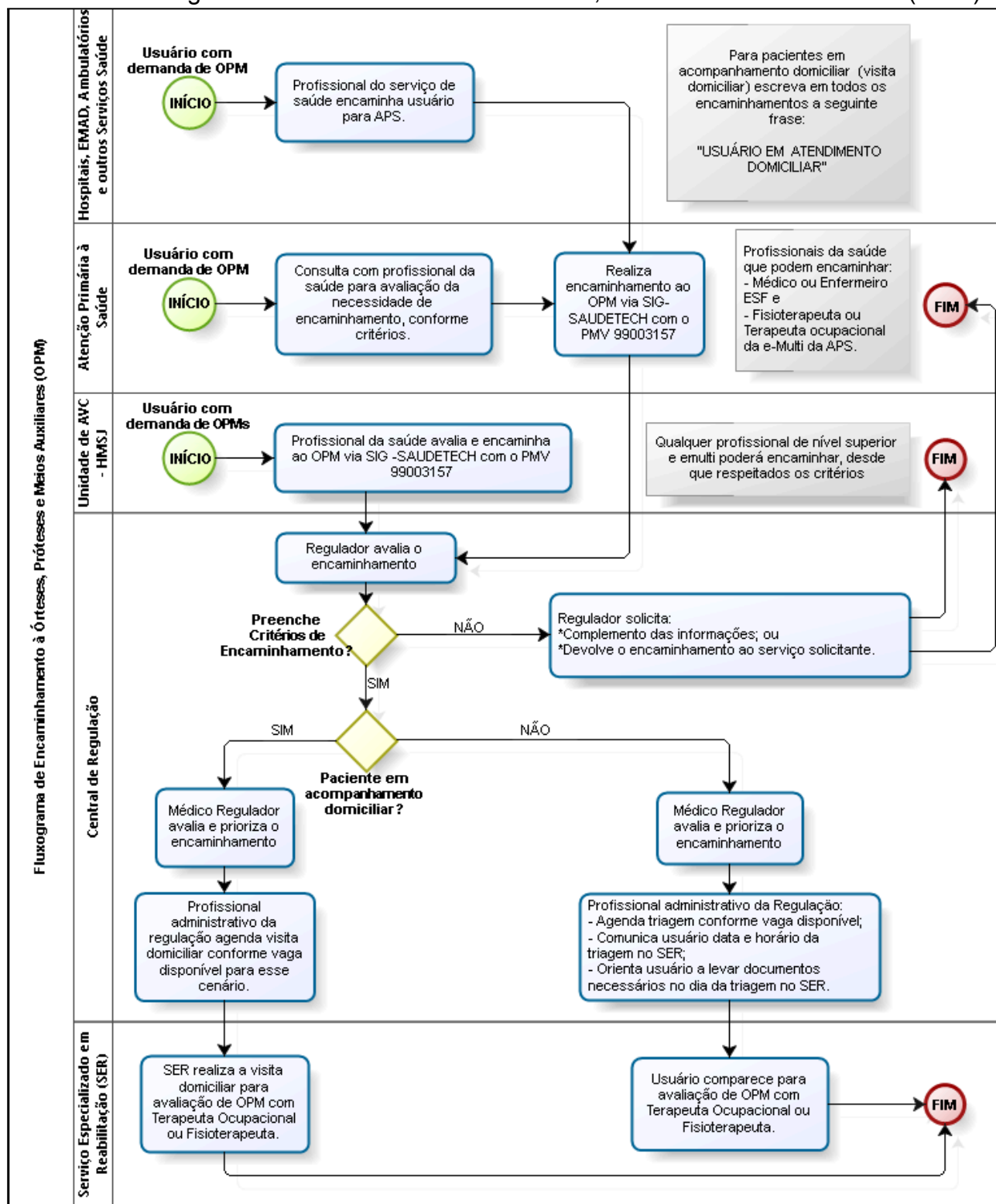
ANEXOS

Anexo 01. Fluxograma de Encaminhamento ao Serviço Especializado em Reabilitação



Fonte: NGQP - SES/Joinville, 2025.

Anexo 02. Fluxograma de Encaminhamento à Órtese, Prótese e Meios Auxiliares (OPM)



Fonte: NGQP - SES/Joinville, 2025.

